خطة العلاج الجاهزة™ · المادة الرئيسية

خطة علاج جاهزة لـ40 نوعًا من الحالات

من التشخيص إلى التثبيت، هيكل جاهز من أربع مراحل لكل نوع من الحالات: افتح الخطة فور انتهاء الفحص وكيّفها وفق سجلات المريض.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

طريقة الاستخدام

فهرس الخطط الأربعين

القسم A · الصنف الأول · الازدحام والمسافات والبروز

القسم B · المشكلات العرضية · العضة المعكوسة

القسم C · حالات الصنف الثاني

القسم D · حالات الصنف الثالث

القسم E · المشكلات العمودية · العضة المفتوحة والعميقة

القسم F · مشكلات الأسنان والمسافة

القسم G · حالات البالغين والحالات متعددة التخصصات والخاصة

طريقة الاستخدام

كُتبت كل خطة بالترتيب نفسه الوارد في **الأداة 4 · المخطّط السريري ذو المراحل الأربع** من دليل طبيب التقويم: التشخيص والسجلات، الأهداف والقرار، التسلسل الميكانيكي، الإنهاء والتثبيت. عند انتهاء الفحص حدّد نوع الحالة، وافتح الخطة، وكيّفها وفق سجلات المريض نفسه.

1. صنّف الحالة إلى مشكلة سهمية وعمودية وعرضية ومشكلة مسافة (مكافأة سريعة: محدِّد نوع الحالة).
2. ابحث في الفهرس عن رقم الخطة الأقرب.
3. أكمل خطوات التشخيص والسجلات بسجلات المريض.
4. اكتب الأهداف والقرار في ملف المريض.
5. انقل التسلسل الميكانيكي إلى خطة الزيارات.
6. راجع بنود الإنهاء والتثبيت قبل يوم نزع الجهاز.

مهم: هذه الخطط هيكل انطلاق. تُحدَّد القوة ومقاس السلك وضبط الجهاز والمدد وفق سجلات المريض ومرحلة نموه وقرارك السريري.

فهرس الخطط الأربعين

A · الصنف الأول · الازدحام والمسافات والبروز

01 الصنف الأول · ازدحام خفيف

02 الصنف الأول · ازدحام متوسط

03 الصنف الأول · ازدحام شديد (خطة بالقلع)

04 قوس متباعد (فُرَج عامة)

05 فُرجة الخط المتوسط العلوي

06 البروز ثنائي الفك

B · المشكلات العرضية · العضة المعكوسة

07 عضة معكوسة أمامية لسن واحدة

08 عضة معكوسة خلفية أحادية الجانب (انزلاق وظيفي)

09 تضيّق فكي علوي ثنائي الجانب في مرحلة النمو

10 تضيّق عرضي لدى البالغ

C · حالات الصنف الثاني

11 الصنف الثاني النوع الأول · تراجع الفك السفلي في مرحلة النمو

12 الصنف الثاني النوع الأول · التمويه لدى البالغ

13 الصنف الثاني النوع الثاني · العضة العميقة

14 صنف ثانٍ سني · التحريك الوحشي للأرحاء

15 صنف ثانٍ أحادي الجانب (subdivision)

16 التدخل المبكر · بروز أفقي زائد وعدم كفاية الشفاه

D · حالات الصنف الثالث

17 صنف ثالث كاذب (وظيفي)

18 تراجع الفك العلوي في مرحلة النمو

19 تمويه صنف ثالث خفيف لدى البالغ

20 التحضير التقويمي قبل جراحة تقويم الفكين

E · المشكلات العمودية · العضة المفتوحة والعميقة

21 عضة مفتوحة مرتبطة بعادة فموية لدى الطفل

22 عضة مفتوحة سنية سنخية لدى البالغ

23	عضة مفتوحة هيكلية (فرط التباعد)
24	عضة عميقة (نقص التباعد)
25	عضة عميقة مع ظهور لثوي زائد

F · مشكلات الأسنان والمسافة

26	ناب علوي منطمر
27	غياب خلقي للرباعية العلوية
28	غياب خلقي للضاحك الثاني السفلي
29	فقدان مبكر لسن لبنية · حافظ المسافة
30	تقويم الرحى المائلة (قبل التعويض)
31	البزوغ المنتبذ للرحى الأولى
32	سن زائدة وتأخر البزوغ

G · حالات البالغين والحالات متعددة التخصصات والخاصة

33	مريض بالغ بمشكلة لثوية
34	ترتيب المسافة قبل الزرعة
35	الانتكاس · ازدحام القواطع السفلية
36	عدم توافق بولتون (رباعيات صغيرة)
37	انحراف الخط المتوسط
38	علاج محدود (المنطقة الأمامية) لدى البالغ
39	تصحيح المنطقة الأمامية في مرحلة الأسنان المختلطة (2×4)
40	ازدحام القواطع السفلية · الحل بالتقليم بين السني (IPR)

القسم A · الصنف الأول · الازدحام والمسافات والبروز

الخطة 01 الصنف الأول · ازدحام خفيف

الموجودات النموذجية: علاقة الرحى والناب من الصنف الأول، العلاقة الهيكلية متوازنة، عدم توافق طول القوس خفيف؛ الملامح الجانبية مقبولة.

أهداف العلاج: حل الازدحام دون قلع · الحفاظ على ميلان القواطع · عدم الإضرار بالملامح الجانبية الحالية

1 · التشخيص والسجلات

- احسب حاجة المسافة بتحليل الأمثلة الدراسية
- سجّل ميلان القواطع في القياسات السيفالومترية
- دوّن النمط الحيوي للثة والدعم العظمي الشفوي

2 · الأهداف والقرار

- خطة دون قلع؛ تقليم بين سني (IPR) محدود عند الحاجة كمصدر للمسافة
- حدّد حدود الميلان الشفوي للقواطع في بداية العلاج

3 · التسلسل الميكانيكي

1. تركيب الحاصرات على القوس كاملًا أو خطة بالمصففات الشفافة
2. التسوية بأسلاك خفيفة مرنة
3. تقليم بين سني (IPR) مضبوط في المناطق الخلفية عند الحاجة
4. الانتقال إلى سلك العمل وضبط شكل القوس

4 · الإنهاء والتثبيت

- افحص نقاط التماس والحواف الحفافية
- قيّم مثبّتًا لسانيًا ثابتًا للمنطقة الأمامية السفلية

خطأ شائع: البدء بالتسوية دون قياس حاجة المسافة ودفع القواطع إلى الأمام دون انتباه.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الخطة 02 الصنف الأول · ازدحام متوسط

الموجودات النموذجية: علاقة من الصنف الأول؛ عدم توافق واضح في طول القوس، ميلان القواطع طبيعي أو زائد قليلًا.

أهداف العلاج: اختيار مصدر المسافة عن وعي · إبقاء وضع القواطع تحت السيطرة · الحفاظ على الإطباق

1 · التشخيص والسجلات

- تحليل المسافة + القياسات السيفالومترية + صورة جانبية للوجه
- قيّم دعم الشفاه والزاوية الأنفية الشفوية
- دوّن حدود اللثة والعظم

2 · الأهداف والقرار

- ترتيب مصادر المسافة: التقليم بين السني (IPR)، ثم التوسيع المحدود، ثم التحريك الوحشي، والقلع خيار أخير
- أكّد القرار بالأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟

3 · التسلسل الميكانيكي

1. تركيب الحاصرات والتسوية بأسلاك خفيفة
2. طبّق مصدر المسافة المختار
3. انتقل إلى سلك العمل مع الحفاظ على شكل القوس
4. افحص الخط المتوسط والإطباق

4 · الإنهاء والتثبيت

- ثنيات الإنهاء والتفاصيل
- خطة المثبّت للفكين العلوي والسفلي

خطأ شائع: بدء العلاج دون تحديد مصدر المسافة ثم تغيير الخطة في منتصف الطريق.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الخطة 03 الصنف الأول · ازدحام شديد (خطة بالقلع)

الموجودات النموذجية: علاقة من الصنف الأول؛ عدم توافق طول القوس لا يمكن حله دون قلع، القواطع بارزة أو دعم الشفاه زائد.

أهداف العلاج: حل الازدحام بالقلع · تحسين وضع القواطع · ضبط الارتكاز

1 · التشخيص والسجلات

- مجموعة سجلات كاملة: الأمثلة الدراسية، الصورة البانورامية، الصورة السيفالومترية، الصور الفوتوغرافية
- حدّد السن الذي سيُقلع وفق صحة الأسنان وحاجة الارتكاز

2 · الأهداف والقرار

- قرار القلع ودرجة الارتكاز (أقصى، متوسط، أدنى)
- ارتكاز بالغرسة المصغّرة أو بالقوس عبر الحنك (TPA) عند الحاجة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية بعد القلع والتحريك الوحشي للأنياب
2. إرجاع القواطع أو إغلاق المسافات بالإرجاع الكتلي (en masse)
3. تحقّق من الارتكاز في كل زيارة متابعة بعلاقة الرحى
4. افحص توازي الجذور بالصورة البانورامية

4 · الإنهاء والتثبيت

- توازي الجذور في مناطق القلع
- خطة مثبّت طويلة الأمد

خطأ شائع: البدء بإغلاق المسافات دون تحديد درجة الارتكاز وفقدان علاقة الرحى.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الخطة 04 قوس متباعد (فُرَج عامة)

الموجودات النموذجية: مسافات على امتداد القوس، الأسنان صغيرة بالنسبة إلى طول القوس أو القوس عريض؛ قد يسهم اللسان أو عادة فموية.

أهداف العلاج: إغلاق المسافات أو توزيعها لأجل الترميم التعويضي · ضبط ميلان القواطع · منع الانتكاس

1 · التشخيص والسجلات

- مقدار المسافات وتوزيعها
- تحليل بولتون (Bolton) لتوافق أحجام الأسنان
- وضع اللسان والسؤال عن العادات الفموية

2 · الأهداف والقرار

- إغلاق كامل أم ترتيب المسافة لاستكمال تعويضي؟ القرار مع طبيب الترميم
- إن وُجدت عادة فموية فعالجها أولًا

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية
2. إغلاق المسافات بسلسلة مطاطية أو بنابض إغلاق
3. راقب الإرجاع الزائد للقواطع
4. اترك مسافة للترميم عند الحاجة

4 · الإنهاء والتثبيت

- اعتبر المثبّت الثابت شرطًا
- إذا كان الترميم مقررًا فخطّط للمثبّت وفق ما بعد الترميم

خطأ شائع: إغلاق المسافات وإنهاء العلاج دون تركيب مثبّت ثابت.

التفاصيل: الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

الخطة 05 فُرجة الخط المتوسط العلوي

الموجودات النموذجية: مسافة بين الثنيتين العلويتين؛ قد يكون اللجام الشفوي سميكًا أو منخفض الالتصاق، مع احتمال وجود سن زائدة.

أهداف العلاج: إغلاق الفُرجة · إزالة السبب · منع الانتكاس

1 · التشخيص والسجلات

- فحص السن الزائدة الأمامية (mesiodens) بصورة ذروية أو بانورامية
- اختبار ابيضاض اللجام
- ميلان القواطع وحجم الأسنان

2 · الأهداف والقرار

- إن وُجد سبب فابدأ به: سن زائدة، لجام، عادة فموية
- خطّط لتوقيت قطع اللجام مع الجرّاح (عادةً بعد الإغلاق)

3 · التسلسل الميكانيكي

1. حاصرات موضعية على الثنايا
2. إغلاق المسافة مع إبقاء الجذور متوازية
3. قطع اللجام بعد الإغلاق عند الحاجة
4. زيارة متابعة

4 · الإنهاء والتثبيت

- مثبِّت حنكي ثابت
- متابعة طويلة الأمد

خطأ شائع: تقريب التيجان بدل الجذور ورؤية الانتكاس خلال وقت قصير.

التفاصيل: الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

الإحالة: سن زائدة أمامية أو لجام سميك: جراحة الفم / أخصائي اللثة.

الخطة 06 البروز ثنائي الفك

الموجودات النموذجية: علاقة من الصنف الأول؛ القواطع العلوية والسفلية بارزة، الشفاه ممتلئة ومشدودة، وقد يوجد إجهاد عند إغلاق الشفاه.

أهداف العلاج: إرجاع القواطع · تقليل دعم الشفاه · إبقاء الارتكاز في أقصاه

1 · التشخيص والسجلات

- ميلان القواطع وخطوط الشفاه في القياسات السيفالومترية
- صورة جانبية وتوقعات المريض الجمالية
- الدعم العظمي واللثة

2 · الأهداف والقرار

- عادةً خطة بقلع أربعة ضواحك
- ارتكاز أقصى: الغرسة المصغّرة أو خيارات الدعم خارج الفم

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية
2. التحريك الوحشي للأنياب أو الإرجاع الكتلي
3. إرجاع القواطع مع ضبط العزم (torque)
4. تابع تغيّر الملامح الجانبية بالصور

4 · الإنهاء والتثبيت

- توازي الجذور والعزم
- مثبِّت علوي وسفلي

خطأ شائع: إرجاع القواطع دون ضبط العزم والإنهاء بقواطع مائلة.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

القسم B · المشكلات العرضية · العضة المعكوسة

الخطة 07 عضة معكوسة أمامية لسن واحدة

الموجودات النموذجية: قاطعة علوية واحدة خلف القواطع السفلية؛ العلاقة الهيكلية متوازنة، وقد يوجد انزلاق أمامي عند الإطباق.

أهداف العلاج: إخراج السن من العضة المعكوسة · إزالة الانزلاق الوظيفي

1 · التشخيص والسجلات

- الانزلاق بين العلاقة المركزية والإطباق
- هل توجد مسافة أمام السن؟
- شكل الجذر والدعم العظمي

2 · الأهداف والقرار

- إذا كانت المسافة كافية فتصحيح موضعي
- إذا لم تكن هناك مسافة فافتح المسافة أولًا

3 · التسلسل الميكانيكي

1. رافع عضة عند الحاجة (لفتح الإطباق)
2. تحريك السن إلى الأمام بحاصرات موضعية أو بجهاز متحرك
3. اعتبره مستقرًا عند تكوّن التغطية العمودية (overbite)

4 · الإنهاء والتثبيت

- التحقق من تغطية عمودية كافية
- مثبِّت لمدة قصيرة

خطأ شائع: إجبار السن دون فتح الإطباق وانكسار الجهاز.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الخطة 08 عضة معكوسة خلفية أحادية الجانب (انزلاق وظيفي)

الموجودات النموذجية: عضة معكوسة في جانب واحد، الفك السفلي ينزلق جانبيًا عند الإطباق، وانحراف الخط المتوسط يزيد عند الإطباق.

أهداف العلاج: إزالة الانزلاق · توسيع القوس العلوي بشكل متناظر

1 · التشخيص والسجلات

- مقارنة الخط المتوسط والفم مفتوح ومغلق
- عرض القوس العلوي وميلان الأرحاء
- مرحلة النمو

2 · الأهداف والقرار

- هل هي أحادية الجانب حقيقية أم ناتجة عن انزلاق؟ ميّز بينهما
- إذا وُجد انزلاق فتوسيع متناظر للقوس العلوي

3 · التسلسل الميكانيكي

1. جهاز التوسيع (الاختيار وفق مرحلة النمو)
2. مدة التثبيت بعد التوسيع
3. إكمال التفاصيل بالعلاج الثابت عند الحاجة

4 · الإنهاء والتثبيت

- فحص الخط المتوسط والإطباق
- مثبِّت عرضي

خطأ شائع: تطبيق ميكانيكا غير متناظرة أحادية الجانب دون ملاحظة الانزلاق.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الخطة 09 تضيّق فكي علوي ثنائي الجانب في مرحلة النمو

الموجودات النموذجية: عضة معكوسة خلفية ثنائية الجانب أو قوس علوي ضيق، ممرات شدقية عريضة، ويجب السؤال عن التنفس الأنفي.

أهداف العلاج: توسيع الفك العلوي هيكليًا · كسب مسافة في طول القوس

1 · التشخيص والسجلات

- تقييم النمو ونضج الدرز
- سجل إطباقي أو بانورامي
- السؤال عن التنفس والعادات الفموية

2 · الأهداف والقرار

- اختيار جهاز التوسيع السريع للفك العلوي (RME)
- إذا وُجدت مشكلة تنفسية فرأي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. تركيب الجهاز وبرنامج التنشيط
2. التثبيت بعد التوسيع بترك الجهاز في وضع غير فعّال
3. ثم علاج ثابت أو مراقبة

4 · الإنهاء والتثبيت

- الثبات العرضي
- مثبّت ليلي عند الحاجة

خطأ شائع: تقصير مدة التثبيت وعودة التوسيع.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الإحالة: التنفس الفموي والشخير: أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

الخطة 10 تضيّق عرضي لدى البالغ

الموجودات النموذجية: مريض بالغ بقوس علوي ضيق وعضة معكوسة؛ الدروز ناضجة، ويوجد تعويض سني.

أهداف العلاج: اختيار التوسيع الممكن · الحفاظ على الحدود اللثوية

1 · التشخيص والسجلات

- ميلان الأرحاء وسماكة العظم الشدقي
- خطر انحسار اللثة
- هل المشكلة سنية أم هيكلية؟

2 · الأهداف والقرار

- التوسيع السني محدود؛ في التضيّق الهيكلي: توسيع مدعوم بالغرسات المصغّرة أو خيارات الدعم الجراحي
- اتخذ القرار مع المريض وعلى خطة مكتوبة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. طريقة التوسيع المختارة
2. سلك وعزم يضبطان ميلان الأرحاء
3. إكمال التفاصيل بالعلاج الثابت

4 · الإنهاء والتثبيت

- فحص اللثة
- مثبّت عرضي

خطأ شائع: محاولة حل مشكلة هيكلية بتوسيع سني وإمالة الأسنان نحو الشدق.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الإحالة: التضيّق الهيكلي: جراحة الفم والوجه والفكين.

القسم C · حالات الصنف الثاني

الخطة 11 الصنف الثاني النوع الأول · تراجع الفك السفلي في مرحلة النمو

الموجودات النموذجية: بروز أفقي (overjet) زائد، رحى من الصنف الثاني، فك سفلي متراجع، مع وجود إمكانية للنمو.

أهداف العلاج: توجيه النمو · تقليل البروز الأفقي · خفض خطر إصابة القواطع

1 · التشخيص والسجلات

- تقييم مرحلة النمو
- المكوّنات الهيكلية والسنية في القياسات السيفالومترية
- قدرة المريض على الالتزام

2 · الأهداف والقرار

- توقيت الجهاز الوظيفي وفق طفرة النمو
- متحرك أم وظيفي ثابت؟ وفق الالتزام

3 · التسلسل الميكانيكي

1. مرحلة الجهاز الوظيفي
2. قياس الرحى والبروز الأفقي في زيارات المتابعة
3. ثم إكمال التفاصيل بالعلاج الثابت

4 · الإنهاء والتثبيت

- استقرار علاقة الصنف الأول
- التثبيت بمثبِّت ليلي أو بجهاز منشِّط (activator)

خطأ شائع: تفويت مرحلة النمو والبدء بالعلاج الوظيفي متأخرًا.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الخطة 12 الصنف الثاني النوع الأول · التمويه لدى البالغ

الموجودات النموذجية: بالغ، علاقة هيكلية من الصنف الثاني خفيفة إلى متوسطة، بروز أفقي زائد، والمريض لا يرغب في الجراحة.

أهداف العلاج: إغلاق البروز الأفقي بحركات سنية · إبقاء الملامح الجانبية مقبولة

1 · التشخيص والسجلات

- حجم الفرق الهيكلي
- تحليل الملامح الجانبية والشفاه
- توقعات المريض الجمالية

2 · الأهداف والقرار

- هل الحالة على حدود التمويه؟ إذا كانت كذلك فاشرح الخيار الجراحي أيضًا
- عادةً خطة بقلع الضواحك العلوية؛ خطة الارتكاز

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية
2. التحريك الوحشي للأنياب العلوية
3. إرجاع القواطع العلوية مع ضبط العزم
4. الإنهاء بناب صنف أول ورحى صنف ثانٍ

4 · الإنهاء والتثبيت

- عزم القواطع والتغطية العمودية
- المثبِّت

خطأ شائع: الاستمرار في حالة تتجاوز حدود التمويه حتى تسوء الملامح الجانبية.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الإحالة: صنف ثانٍ هيكلي واضح: رأي في جراحة تقويم الفكين.

الخطة 13 الصنف الثاني النوع الثاني · العضة العميقة

الموجودات النموذجية: الثنايا العلوية مائلة إلى الخلف، وقد تكون الرباعيات بارزة، عضة عميقة، وعضلات شفاه قوية.

أهداف العلاج: تصحيح ميلان القواطع · فتح العضة العميقة · تصحيح علاقة الصنف الثاني

1 · التشخيص والسجلات

- ميلان القواطع والتغطية العمودية
- ظهور اللثة وخط الابتسامة
- السؤال عن المفصل الفكي الصدغي

2 · الأهداف والقرار

- صحّح عزم القواطع أولًا ثم عالج المشكلة السهمية
- إذا وُجد نمو فافتح القواطع قبل الجهاز الوظيفي

3 · التسلسل الميكانيكي

1. تحريك القواطع العلوية إلى الأمام وضبط العزم
2. ميكانيكا فتح العضة (غرز القواطع أو بثق الأسنان الخلفية، وفق الحالة)
3. تصحيح الصنف الثاني

4 · الإنهاء والتثبيت

- ثبات التغطية العمودية
- مثبّت حنكي علوي

خطأ شائع: استخدام مطاطات الصنف الثاني دون فتح العضة العميقة وإجهاد القواطع.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الخطة 14 صنف ثانٍ سني · التحريك الوحشي للأرحاء

الموجودات النموذجية: العلاقة الهيكلية متوازنة، الأرحاء العلوية في وضع أنسي، رحى من الصنف الثاني، والملامح الجانبية جيدة.

أهداف العلاج: نقل الأرحاء إلى الصنف الأول · علاج دون قلع

1 · التشخيص والسجلات

- هل توجد مسافة خلف الرحى؟ (أضراس العقل)
- النمط العمودي للوجه

2 · الأهداف والقرار

- جهاز التحريك الوحشي أو تحريك وحشي مدعوم بالغرسات المصغّرة
- خطة لمنع فقدان الارتكاز

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التحريك الوحشي للأرحاء
2. التحريك الوحشي المتتابع للضواحك والأنياب
3. إرجاع المنطقة الأمامية

4 · الإنهاء والتثبيت

- رحى وناب من الصنف الأول
- المثبّت

خطأ شائع: إغفال تقدّم المنطقة الأمامية (فقدان الارتكاز) أثناء التحريك الوحشي.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الخطة 15 صنف ثانٍ أحادي الجانب (subdivision)

الموجودات النموذجية: صنف أول في جانب وصنف ثانٍ في الجانب الآخر؛ وقد يرافقه انحراف في الخط المتوسط.

أهداف العلاج: تصحيح عدم التناظر · محاذاة الخطوط المتوسطة

1 · التشخيص والسجلات

- هل عدم التناظر سني أم هيكلي؟
- موضع الخطوط المتوسطة بالنسبة إلى الوجه
- هل يوجد انزلاق وظيفي؟

2 · الأهداف والقرار

- قلع غير متناظر، أو مطاطات غير متناظرة، أو تحريك وحشي أحادي الجانب
- في عدم التناظر الهيكلي: الخيار الجراحي

3 · التسلسل الميكانيكي

1. تسوية متناظرة
2. الميكانيكا غير المتناظرة المختارة
3. فحص الخط المتوسط في كل زيارة

4 · الإنهاء والتثبيت

- الخط المتوسط وعلاقة الناب
- المثبِّت

خطأ شائع: إجبار عدم تناظر هيكلي بميكانيكا سنية.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الخطة 16 التدخل المبكر · بروز أفقي زائد وعدم كفاية الشفاه

الموجودات النموذجية: مرحلة الأسنان المختلطة، بروز أفقي واضح، الشفاه لا تغطي القواطع، وخطر الإصابة مرتفع.

أهداف العلاج: تقليل خطر الإصابة · توجيه النمو

1 · التشخيص والسجلات

- تاريخ الإصابات
- العادات الفموية (مص الإصبع)
- مرحلة النمو

2 · الأهداف والقرار

- مرحلة مبكرة أم تأجيل إلى المرحلة الثانية؟ وفق الخطر والالتزام
- ناقش مع الوالدين خطة من مرحلتين

3 · التسلسل الميكانيكي

1. ضبط العادة الفموية
2. جهاز وظيفي أو ميكانيكا ثابتة محدودة
3. المراقبة وتوقيت المرحلة الثانية

4 · الإنهاء والتثبيت

- مثبِّت يحافظ على المكتسبات
- تقييم المرحلة الثانية

خطأ شائع: إطالة المرحلة المبكرة وإرهاق المريض والوالدين.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

القسم D · حالات الصنف الثالث

الخطة 17 صنف ثالث كاذب (وظيفي)

الموجودات النموذجية: انزلاق أمامي عند الإطباق، القواطع حدًّا لحد في العلاقة المركزية، والعلاقة الهيكلية طبيعية.

أهداف العلاج: إزالة الانزلاق · إعادة القواطع إلى بروز أفقي طبيعي

1 · التشخيص والسجلات

- الفرق بين العلاقة المركزية والإطباق
- ميلان القواطع
- التاريخ العائلي

2 · الأهداف والقرار

- التصحيح المبكر مفيد عادةً
- قد تكفي ميكانيكا بسيطة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. تحريك القواطع العلوية إلى الأمام
2. رافع عضة عند الحاجة
3. الإنهاء عند تكوّن بروز أفقي وتغطية عمودية موجبين

4 · الإنهاء والتثبيت

- فحص التغطية العمودية
- متابعة النمو

خطأ شائع: الظن بأن صنفًا ثالثًا هيكليًا حقيقيًا هو صنف كاذب.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الخطة 18 تراجع الفك العلوي في مرحلة النمو

الموجودات النموذجية: صنف ثالث هيكلي، فك علوي متراجع، مرحلة الأسنان المختلطة أو بداية الإطباق الدائم.

أهداف العلاج: دعم نمو الفك العلوي · الحصول على بروز أفقي موجب

1 · التشخيص والسجلات

- مرحلة النمو
- موضع الفكين العلوي والسفلي في القياسات السيفالومترية
- التاريخ العائلي والإنذار

2 · الأهداف والقرار

- قناع الوجه (مع التوسيع عند الحاجة) في مرحلة مبكرة
- اشرح للوالدين منذ البداية احتمال الانتكاس واحتمال الجراحة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. توسيع الفك العلوي عند الحاجة
2. برنامج قناع الوجه
3. تصحيح زائد ثم مراقبة

4 · الإنهاء والتثبيت

- المتابعة حتى نهاية النمو
- مرحلة ثانية عند الحاجة

خطأ شائع: البدء دون شرح الإنذار للوالدين ثم مفاجأتهم لاحقًا بالحاجة إلى الجراحة.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الخطة 19 تمويه صنف ثالث خفيف لدى البالغ

الموجودات النموذجية: بالغ، صنف ثالث هيكلي خفيف، قواطع حدًّا لحد أو بروز أفقي سالب خفيف، والملامح الجانبية مقبولة.

أهداف العلاج: بروز أفقي موجب · إبقاء ميلان القواطع ضمن حدود مقبولة

1 · التشخيص والسجلات

- حجم الفرق الهيكلي
- الدعم العظمي للقواطع السفلية
- توقعات المريض

2 · الأهداف والقرار

- قيّم حدود التمويه؛ إن كانت الحالة على الحد فاشرح الخيار الجراحي
- مصدر المسافة في القوس السفلي: التقليم بين السني (IPR) أو القلع أو التحريك الوحشي

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية
2. ميكانيكا الصنف الثالث (مطاطات أو مدعومة بالغرسات المصغّرة)
3. ضبط عزم القواطع

4 · الإنهاء والتثبيت

- التغطية العمودية والبروز الأفقي
- المثبِّت

خطأ شائع: إمالة القواطع السفلية إلى الخلف حتى تخرج من العظم.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الإحالة: صنف ثالث هيكلي واضح: جراحة تقويم الفكين.

الخطة 20 التحضير التقويمي قبل جراحة تقويم الفكين

الموجودات النموذجية: عدم توافق هيكلي واضح، مع تعويض سني، والمريض منفتح على الجراحة.

أهداف العلاج: إزالة التعويض · جعل القوسين متوافقين · سجلات جاهزة للجراحة

1 · التشخيص والسجلات

- مجموعة سجلات كاملة وتقييم مشترك مع الجرّاح
- اتجاه التعويض

2 · الأهداف والقرار

- الخطة الجراحية مع الجرّاح؛ دور التقويم هو إزالة التعويض وتوافق القوسين
- إذا لزم القلع فيكون في اتجاه إزالة التعويض

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية وإزالة التعويض
2. تنسيق القوسين
3. الأمثلة الدراسية والسجلات قبل الجراحة
4. إكمال التفاصيل بعد الجراحة

4 · الإنهاء والتثبيت

- استقرار الإطباق
- المثبِّت

خطأ شائع: زيادة التعويض وجعل الحالة أصعب على الجراحة.

التفاصيل: الوحدة 05 · المشكلات السهمية: الصنف الثاني والثالث

الإحالة: خطة مشتركة مع جراحة الفم والوجه والفكين.

القسم E · المشكلات العمودية · العضة المفتوحة والعميقة

الخطة 21 عضة مفتوحة مرتبطة بعادة فموية لدى الطفل

الموجودات النموذجية: مرحلة الأسنان المختلطة، عضة مفتوحة أمامية، وتاريخ مص الإصبع أو دفع اللسان.

أهداف العلاج: ترك العادة الفموية · السماح للقواطع بالانغلاق تلقائيًا

1 · التشخيص والسجلات

- تاريخ العادة وتكرارها
- وضع اللسان والبلع
- هل يوجد مكوّن هيكلي؟

2 · الأهداف والقرار

- العادة أولًا؛ الجهاز وسيلة تذكير وليس عقوبة
- دعم وظيفي عضلي عند الحاجة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. جهاز كسر العادة (وفق الحالة)
2. تمارين اللسان
3. مراقبة الانغلاق

4 · الإنهاء والتثبيت

- راقب عودة العادة
- تقييم المرحلة الثانية

خطأ شائع: محاولة إغلاق العضة بميكانيكا ثابتة دون حل العادة.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الإحالة: مشكلة اللسان والبلع: العلاج الوظيفي العضلي / أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

الخطة 22 عضة مفتوحة سنية سنخية لدى البالغ

الموجودات النموذجية: بالغ، عضة مفتوحة أمامية، البنية الهيكلية طبيعية نسبيًا، وقد يسهم وضع اللسان.

أهداف العلاج: إغلاق العضة المفتوحة · تحقيق الثبات

1 · التشخيص والسجلات

- التمييز بين المكوّن السني والهيكلي
- وضع اللسان
- علاقة القواطع بالشفاه والابتسامة

2 · الأهداف والقرار

- غرز الأسنان الخلفية (مدعوم بالغرسات المصغّرة) أو بثق الأسنان الأمامية: الاختيار وفق الابتسامة
- خطة لتدريب اللسان

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية
2. الميكانيكا العمودية المختارة
3. فحص التغطية العمودية

4 · الإنهاء والتثبيت

- ضبط عادة اللسان
- مثبّت طويل الأمد

خطأ شائع: إطالة القواطع أكثر من اللازم وإفساد الابتسامة والثبات.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الخطة 23 عضة مفتوحة هيكلية (فرط التباعد)

الموجودات النموذجية: ارتفاع الوجه السفلي كبير، مستوى الفك السفلي شديد الميل، وعضة مفتوحة أمامية.

أهداف العلاج: الضبط العمودي · إغلاق العضة أو التحضير للجراحة

1 · التشخيص والسجلات

- القياسات السيفالومترية العمودية
- عدم كفاية الشفاه وظهور اللثة

2 · الأهداف والقرار

- تمويه (غرز الأسنان الخلفية) أم جراحة؟ وفق الفرق الهيكلي
- تجنّب الميكانيكا التي تسبب البثق

3 · التسلسل الميكانيكي

1. ضبط الارتكاز العمودي
2. غرز الأسنان الخلفية بالغرسة المصعّرة (إذا اختير)
3. إكمال التفاصيل

4 · الإنهاء والتثبيت

- الثبات العمودي
- المثبِّت

خطأ شائع: إطالة الأرحاء بمطاطات الصنف الثاني أو الثالث وتكبير العضة المفتوحة.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الإحالة: عضة مفتوحة هيكلية واضحة: جراحة تقويم الفكين.

الخطة 24 عضة عميقة (نقص التباعد)

الموجودات النموذجية: وجه سفلي قصير، عضة عميقة، وعضلات مضغ قوية.

أهداف العلاج: فتح العضة العميقة · تغطية عمودية مستقرة

1 · التشخيص والسجلات

- القياسات العمودية وخط الابتسامة
- تماس القواطع السفلية مع النسج الحنكية العلوية

2 · الأهداف والقرار

- قد يكون بثق الأسنان الخلفية أنسب في هذا النمط من الوجه
- غرز القواطع وفق الابتسامة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. رافع عضة
2. فتح العضة بأسلاك ذات انحناء معكوس
3. فحص التغطية العمودية

4 · الإنهاء والتثبيت

- حماية العضة بمثبِّت حنكي علوي
- متابعة التغطية العمودية

خطأ شائع: لصق الحاصرات السفلية دون فتح العضة ثم الانشغال بانفصال الحاصرات.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الخطة 25 عضة عميقة مع ظهور لثوي زائد

الموجودات النموذجية: عضة عميقة، ظهور زائد للثة عند الابتسام، والقواطع العلوية متطاولة.

أهداف العلاج: غرز القواطع العلوية · تحسين جمال الابتسامة

1 · التشخيص والسجلات

- ظهور القواطع في الراحة وعند الابتسام
- طول الشفة وحركتها
- هل السبب لثوي أم سني؟

2 · الأهداف والقرار

- غرز القواطع العلوية (بالغرسة المصغّرة أو بقوس الغرز)
- إذا كان السبب لثويًا فرأي أخصائي اللثة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية
2. غرز القواطع العلوية
3. ضبط العزم

4 · الإنهاء والتثبيت

- فحص نهائي بصورة للابتسامة
- المثبِّت

خطأ شائع: فقدان العزم أثناء غرز القواطع وإمالة الجذور نحو الحنك.

التفاصيل: الوحدة 06 · المشكلات العمودية والعرضية

الإحالة: زيادة اللثة: أخصائي اللثة.

القسم F · مشكلات الأسنان والمسافة

الخطة 26 ناب علوي منطمر

الموجودات النموذجية: الناب لم يبزغ، وقد يبقى الناب اللبني في مكانه، بموضع حنكي أو شدقي.

أهداف العلاج: توجيه الناب إلى القوس · حماية جذور الأسنان المجاورة

1 · التشخيص والسجلات

- تقييم الموضع ثلاثي الأبعاد (التصوير المقطعي بالحزمة المخروطية CBCT عند الحاجة)
- فحص امتصاص جذر الرباعية
- هل توجد مسافة؟

2 · الأهداف والقرار

- كشف جراحي + سحب أم قلع؟ وفق الموضع والإنذار
- خطة مشتركة مع الجرّاح

3 · التسلسل الميكانيكي

1. فتح المسافة أولًا وسلك ارتكاز متين
2. الكشف الجراحي وتثبيت الملحق
3. السحب بقوة خفيفة
4. إدخاله في القوس وضبط العزم

4 · الإنهاء والتثبيت

- حالة اللثة وموضع الجذر
- المثبِّت

خطأ شائع: البدء بالسحب دون فتح المسافة ودون سلك ارتكاز، وتحريك الأسنان المجاورة.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الإحالة: جراحة الفم (الكشف) والأشعة CBCT J عند الحاجة.

الخطة 27 غياب خلقي للرباعية العلوية

الموجودات النموذجية: غياب رباعية علوية أو اثنتين؛ وقد تكون الأنياب في وضع أنسي.

أهداف العلاج: قرار فتح المسافة (زرعة/تعويض) أو إغلاقها (تشكيل الناب)

1 · التشخيص والسجلات

- لون الناب وشكله ومستوى لثته
- علاقة الإطباق
- عمر المريض والخيارات الترميمية

2 · الأهداف والقرار

- القرار مع طبيب الترميم: فتح أم إغلاق؟
- يُسلَّم القرار للمريض كخطة مكتوبة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. ميكانيكا في الاتجاه المختار: فتح المسافة أو إغلاقها
2. خطة تشكيل الناب والضاحك
3. توازي الجذور

4 · الإنهاء والتثبيت

- حل مؤقت وفق توقيت الترميم
- المثبِّت

خطأ شائع: تحديد مقدار المسافة دون استشارة طبيب الترميم.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الإحالة: طبيب التعويضات / الزرعات.

الخطة 28 غياب خلقي للضاحك الثاني السفلي

الموجودات النموذجية: غياب الضاحك الثاني السفلي، وقد تبقى الرحى اللبنية في مكانها.

أهداف العلاج: قرار الحفاظ على الرحى اللبنية أو إغلاق المسافة أو الحل التعويضي

1 · التشخيص والسجلات

- حالة جذور الرحى اللبنية وانخسافها الإطباقي (infraocclusion)
- الملامح الجانبية ووضع الازدحام

2 · الأهداف والقرار

- إذا وُجد ازدحام فقد يكون إغلاق المسافة مفيدًا
- إذا كانت الرحى اللبنية بحالة جيدة فيمكن الحفاظ عليها

3 · التسلسل الميكانيكي

1. الخطة المختارة: الإغلاق أو الحفاظ
2. في الإغلاق: ضبط ارتكاز الأرحاء

4 · الإنهاء والتثبيت

- الإطباق وتوازي الجذور
- المثبِّت

خطأ شائع: الانتظار لسنوات دون مراقبة الانخساف الإطباقي للرحى اللبنية.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الخطة 29 فقدان مبكر لسن لبنية · حافظ المسافة

الموجودات النموذجية: فقدان مبكر لرحى لبنية، والسن الدائمة تحتها لم تبزغ بعد.

أهداف العلاج: الحفاظ على المسافة · بزوغ طبيعي للسن الدائمة

1 · التشخيص والسجلات

- موضع برعم السن الدائمة
- هل بدأ فقدان المسافة؟

2 · الأهداف والقرار

- نوع حافظ المسافة (ثابت/متحرك) ومدته
- إذا وُجد فقدان مسافة فخطة لاستعادتها

3 · التسلسل الميكانيكي

1. تركيب حافظ المسافة
2. زيارات متابعة منتظمة
3. نزعه عند بزوغ السن الدائمة

4 · الإنهاء والتثبيت

- متابعة البزوغ

خطأ شائع: ترك حافظ المسافة دون متابعة ومنع بزوغ السن الدائمة.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الخطة 30 تقويم الرحى المائلة (قبل التعويض)

الموجودات النموذجية: بالغ، رحى سفلية مائلة نحو الفراغ، مع تخطيط لتعويض أو زرعة.

أهداف العلاج: تقويم الرحى · فتح مسافة متوازية للتعويض

1 · التشخيص والسجلات

- الحالة اللثوية والعظم
- تطاول السن المقابلة

2 · الأهداف والقرار

- هل تكفي ميكانيكا موضعية؟
- مقدار المسافة مع طبيب التعويضات

3 · التسلسل الميكانيكي

1. حاصرات موضعية وارتكاز
2. نابض تقويم الرحى أو ميكانيكا مدعومة بالغرسة المصغّرة
3. فحص الإطباق

4 · الإنهاء والتثبيت

- الحاجة إلى مثبِّت بعد التعويض أو الزرعة

خطأ شائع: إطالة الرحى أثناء تقويمها وإحداث رضّ إطباقي.

التفاصيل: الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

الإحالة: طبيب التعويضات / الزرعات وأخصائي اللثة.

الخطة 31 البزوغ المنتبذ للرحى الأولى

الموجودات النموذجية: الرحى الأولى العلوية عالقة بالجذر الوحشي للرحى اللبنية الثانية.

أهداف العلاج: تمكين الرحى من البزوغ · الحفاظ على الرحى اللبنية إن أمكن

1 · التشخيص والسجلات

- درجة الانحشار بالصورة البانورامية
- امتصاص الرحى اللبنية

2 · الأهداف والقرار

- مراقبة قصيرة لاحتمال التصحيح التلقائي أم تدخّل؟

3 · التسلسل الميكانيكي

1. فاصل أو جهاز تحريك وحشي بسيط
2. زيارة متابعة بعد البزوغ

4 · الإنهاء والتثبيت

- فحص فقدان المسافة

خطأ شائع: المراقبة لمدة طويلة وفقدان الرحى اللبنية والمسافة.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الخطة 32 سن زائدة وتأخر البزوغ

الموجودات النموذجية: سن دائمة لم تتمكن من البزوغ، مع وجود سن زائدة في المنطقة.

أهداف العلاج: إزالة العائق · تمكين السن من البزوغ

1 · التشخيص والسجلات

- تحديد الموضع شعاعيًا
- تكوّن الجذر

2 · الأهداف والقرار

- قلع السن الزائدة ثم المراقبة، أم القلع + الكشف؟ القرار مع الجرّاح

3 · التسلسل الميكانيكي

1. فتح المسافة والحفاظ عليها
2. الجراحة
3. السحب عند الحاجة

4 · الإنهاء والتثبيت

- حالة الجذر واللثة
- المثبِّت

خطأ شائع: إجراء الجراحة دون فتح المسافة ثم انتظار بزوغ السن.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

الإحالة: جراحة الفم.

القسم G · حالات البالغين والحالات متعددة التخصصات والخاصة

الخطة 33 مريض بالغ بمشكلة لثوية

الموجودات النموذجية: فقد عظمي، قواطع مهاجرة ومتباعدة على شكل مروحة، تلقّى علاجًا لثويًا أو يحتاج إليه.

أهداف العلاج: محاذاة الأسنان بقوة خفيفة · الحفاظ على صحة اللثة

1 · التشخيص والسجلات

- الحالة اللثوية الحالية واستقرارها
- مستويات العظم

2 · الأهداف والقرار

- لا تبدأ قبل اكتمال العلاج اللثوي
- قوة خفيفة وميكانيكا بسيطة

3 · التسلسل الميكانيكي

1. موافقة أخصائي اللثة
2. تسوية بقوة خفيفة
3. فحوص لثوية متقاربة

4 · الإنهاء والتثبيت

- مثبِّت ثابت دائم
- برنامج رعاية لثوية

خطأ شائع: تطبيق قوة تقويمية في وجود مرض لثوي نشط.

التفاصيل: الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

الإحالة: متابعة مشتركة مع أخصائي اللثة.

الخطة 34 ترتيب المسافة قبل الزرعة

الموجودات النموذجية: المسافة في منطقة السن المفقودة غير كافية أو الجذور مائلة، مع تخطيط لزرعة.

أهداف العلاج: مسافة كافية على مستوى التاج والجذر · جذور مجاورة متوازية

1 · التشخيص والسجلات

- مقدار المسافة المطلوبة مع طبيب الزرعات
- صورة شعاعية لتوازي الجذور

2 · الأهداف والقرار

- ميكانيكا فتح المسافة والحل المؤقت

3 · التسلسل الميكانيكي

1. ميكانيكا موضعية أو على القوس كاملًا
2. فحص توازي الجذور
3. الحفاظ على المسافة حتى موعد الزرعة

4 · الإنهاء والتثبيت

- تعويض مؤقت ومثبِّت
- زيارة متابعة بعد الزرعة

خطأ شائع: فتح المسافة على مستوى التاج فقط وتقريب الجذور.

التفاصيل: الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة

الإحالة: طبيب الزرعات.

الخطة 35 الانتكاس · ازدحام القواطع السفلية

الموجودات النموذجية: تلقّى علاجًا تقويميًا سابقًا، لم يستخدم المثبِّت، وظهر ازدحام جديد في القواطع السفلية.

أهداف العلاج: تصحيح الازدحام مجددًا · تثبيت دائم هذه المرة

1 · التشخيص والسجلات

- تاريخ العلاج السابق والمثبِّت
- حاجة المسافة

2 · الأهداف والقرار

- العلاج المحدود (المصففات الشفافة أو حاصرات موضعية) كافٍ في أغلب الأحيان
- قد يلزم التقليم بين السني (IPR)

3 · التسلسل الميكانيكي

1. محاذاة موضعية
2. التقليم بين السني (IPR) عند الحاجة
3. مثبِّت ثابت

4 · الإنهاء والتثبيت

- المثبِّت اللساني الثابت شرط
- برنامج زيارات متابعة للمثبِّت

خطأ شائع: التصحيح مرة أخرى دون وضع خطة للمثبِّت من جديد.

التفاصيل: الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

الخطة 36 عدم توافق بولتون (رباعيات صغيرة)

الموجودات النموذجية: رباعيات علوية صغيرة أو وتدية الشكل، مع مسافات في المنطقة الأمامية أو عدم توافق في البروز الأفقي.

أهداف العلاج: إطباق متوافق في المنطقة الأمامية · الجمال

1 · التشخيص والسجلات

- تحليل بولتون (Bolton)
- الخيارات الترميمية

2 · الأهداف والقرار

- توزيع المسافات حول الرباعيات ثم الترميم، أم التقليم بين السني (IPR)؟ مع طبيب الترميم

3 · التسلسل الميكانيكي

1. المحاذاة
2. توزيع المسافات
3. إكمال التفاصيل بعد الترميم

4 · الإنهاء والتثبيت

- مثبِّت بعد الترميم

خطأ شائع: إغلاق المنطقة الأمامية دون حساب عدم توافق بولتون وإفساد البروز الأفقي.

التفاصيل: الوحدة 08 · الإنهاء والثبات

الإحالة: طبيب الترميم / طب الأسنان التجميلي.

الخطة 37 انحراف الخط المتوسط

الموجودات النموذجية: الخط المتوسط العلوي والسفلي منحرفان بالنسبة إلى بعضهما أو إلى الوجه.

أهداف العلاج: محاذاة الخطوط المتوسطة · إيجاد السبب

1 · التشخيص والسجلات

- أي خط متوسط منحرف؟ بالنسبة إلى الوجه
- انزلاق وظيفي، أو ازدحام غير متناظر، أو سن مفقودة

2 · الأهداف والقرار

- وفق السبب: قلع غير متناظر، مطاطات غير متناظرة، توزيع المسافات

3 · التسلسل الميكانيكي

1. التسوية
2. الميكانيكا غير المتناظرة المختارة
3. قياس الخط المتوسط في كل زيارة

4 · الإنهاء والتثبيت

- الخط المتوسط وعلاقة الناب
- المثبِّت

خطأ شائع: محاذاة الأسنان بعضها مع بعض دون النظر إلى الخط المتوسط للوجه.

التفاصيل: الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا

الخطة 38 علاج محدود (المنطقة الأمامية) لدى البالغ

الموجودات النموذجية: بالغ يشكو فقط من مشكلة جمالية في المنطقة الأمامية، والإطباق الخلفي جيد.

أهداف العلاج: تصحيح المنطقة الأمامية · عدم الإخلال بالإطباق الخلفي

1 · التشخيص والسجلات

- هل المشكلة محدودة فعلًا؟
- حاجة المسافة والإطباق

2 · الأهداف والقرار

- اشرح للمريض كتابيًا حدود العلاج المحدود
- المصففات الشفافة أو ميكانيكا ثابتة موضعية

3 · التسلسل الميكانيكي

1. محاذاة موضعية
2. التقليم بين السني (IPR) عند الحاجة
3. فحص الإطباق

4 · الإنهاء والتثبيت

- مثبِّت ثابت أو متحرك

خطأ شائع: إدخال مشكلة لا يحلها العلاج المحدود في علاج محدود.

التفاصيل: الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا

الخطة 39 تصحيح المنطقة الأمامية في مرحلة الأسنان المختلطة (4×2)

الموجودات النموذجية: مرحلة الأسنان المختلطة، ازدحام أو دوران أو عضة معكوسة في القواطع.

أهداف العلاج: محاذاة القواطع · تقليل خطر الإصابة والمشكلات الوظيفية

1 · التشخيص والسجلات

- براعم الأسنان الدائمة ووضع المسافة
- علاقة الرحى

2 · الأهداف والقرار

- مرحلة محدودة وقصيرة؛ اشرح للوالدين المرحلة الثانية منذ البداية

3 · التسلسل الميكانيكي

1. أطواق على الأرحاء وحاصرات على القواطع
2. المحاذاة بأسلاك خفيفة
3. توازي الجذور

4 · الإنهاء والتثبيت

- المثبِّت ومتابعة المرحلة الثانية

خطأ شائع: إمالة الجذور القريبة من براعم الأنياب دون انتباه.

التفاصيل: الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا

الخطة 40 ازدحام القواطع السفلية · الحل بالتقليم بين السني (IPR)

الموجودات النموذجية: ازدحام خفيف في القواطع السفلية، أسنان مثلثية الشكل، وخطر ظهور المثلثات السوداء.

أهداف العلاج: محاذاة دون قلع · تقليل المثلثات السوداء

1 · التشخيص والسجلات

- شكل السن وسماكة المينا
- حالة الحليمة اللثوية
- حاجة المسافة

2 · الأهداف والقرار

- خطّط لمقدار التقليم بين السني (IPR) وفق تحليل المسافة وسجّله

3 · التسلسل الميكانيكي

1. المحاذاة
2. التقليم بين السني (IPR) المخطط له
3. إغلاق المسافات

4 · الإنهاء والتثبيت

- مثبِّت لساني ثابت

خطأ شائع: إجراء التقليم بين السني (IPR) دون خطة ودون تسجيل.

التفاصيل: الوحدة 04 · إدارة المسافة: التقليم بين السني والتوسيع والقلع

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

بعد اختيار الخطة، اختر تسلسل الأسلاك المناسب من **«جداول تسلسل الأسلاك القوسية»** والجهاز من **«دليل اختيار الجهاز: أي مشكلة، أي جهاز»**. ولتعميق مبررات الخطة ارجع في دليل طبيب التقويم إلى **الوحدة 03 · التخطيط السريري: من قائمة المشكلات إلى الميكانيكا**.